

Bronquiolite · gravidade e suporte

Bronquiolite viral aguda: primeiro quadro de sibilância em lactente, sobretudo < 12 meses, no outono/inverno. O tratamento é suporte; broncodilatador e corticóide não são rotina.

Diagnóstico clínico

- Pródromo viral !' tosse, taquipneia, sibilos/estertores, hiperinsuflação
- Principal agente: VSR (outros: rinovírus, metapneumovírus)
- RX não é rotina — só se dúvida de pneumonia/complicação
- Fatores de risco: prematuridade, cardiopatia, imunodeficiência, < 3 meses

Conduta — o essencial

Fazer | Evitar de rotina

O₂, se hipoxemia | Broncodilatador sistemático

Hidratação / fracionar dietas | Corticóide isolado

Aspiração de vias aéreas superiores | Fisioterapia 'agressiva' sem indicação

Internar se apneia / falência | Antibiótico sem coinfeção bacteriana

Sinais de alarme para os pais

Dica - Sinais de alarme para os pais

Cianose, pausas respiratórias, recusa total, sonolência, tiragem intensa — retorno imediato.

Classifique pelo esforço respiratório, saturação e capacidade de se alimentar.

Bronquiolite - gravidade

Leve / moderada / grave

Leve

FR pouco elevada

SatO₂ boa

Alimenta bem

Casa + orientacao

Moderada

Tiragem

SatO₂ limiar

Ingesta reduzida

Observacao / O₂

Grave

Batimento de asa

SatO₂ baixa

Apneia / letargia

Internacao / suporte

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não trate bronquiolite típica como asma do lactente: ;#" R 6÷ ticoide não melhoram desfecho na maioria e não são primeira linha.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1